

Méningites à LCS clair

Introduction :

- Les méningites à LCS clair constituent un cadre nosologique regroupant des méningites et des méningo encéphalites essentiellement communautaires se caractérisant par un aspect macroscopique clair du LCS
- Les étiologies sont diverses : bactériennes, virales, parasitaires, mycosiques, néoplasiques... Certaines sont bénignes et souvent d'étiologie virale, d'autres sont graves et engagent le pronostic vital (tuberculose, MEH...)
- Elles se rencontrent à tout âge, mais la distribution est fonction de l'étiologie
- Le défi du médecin est d'arriver à un diagnostic par des arguments anamnestiques, cliniques, biologiques en commençant par éliminer les étiologies graves (tuberculose, herpès...) les étiologies graves (tuberculose, herpès...)
- Elles sont à déclaration obligatoire.

Identifier

- La méningite tuberculeuse : grave
- Méningoencéphalite herpétique
- Méningite purulente décapitée

Diagnostic positif :

Circonstances imposant la PL :

- Syndrome méningé fébrile aigu
- Céphalées fébriles
- Signes neurologiques fébriles focalisés ou non
- Tableau psychiatrique fébrile
- Fièvre aiguë sans foyer infectieux évident chez le nourrisson
- Fièvre prolongée inexpliquée
- Tableau de polysérite

Interrogatoire :

- Mode d'installation du syndrome méningé : brutal, progressif
- Prise d'antibiotique.
- Notion de Contage tuberculeux
- Existence d'une pathologie infectieuse au cours des jours précédents : Grippe, Diarrhée, Parotidite, éruption

Diagnostic clinique :

Syndrome méningé :

Signes fonctionnels

- Céphalées en casque violentes ne cédant pas aux antalgiques avec photophobie, vomissements en jet , troubles du transit
- Évoluant dans un contexte infectieux variable selon l'étiologie

Signes physiques :

- Raideur de la nuque
- Signe de brudzinski
- Signe de kernig
- Troubles vasomoteurs

Signes encéphalitiques :

- Troubles de la conscience
- Signes de focalisation
- Signes neurovégétatifs engageant le pronostic vital.
- La ponction lombaire retire un liquide clair (transparent, eau de roche). La clarté du LCS est fonction de la cellularité(<500 éléments/mm³) et du taux de protéines

Diagnostic biologique :

•L'étude de la composition du LCS est essentielle à la démarche diagnostique, deux situations peuvent se voir

•LCS clair et de composition normale : aspect eau de roche, cytologie < 10 éléments/mm³, albumine (g/l), glucose (g/l).

Il s'agit d'un méningisme qui peut s'observer au cours d'une infection quelconque (angine, pneumopathie...)

LCR clair riche en éléments : plus de 10 éléments/mm³, Il est pathologique. Les étiologies sont diverses (virales, bactériennes, parasitaires mycosique...).

• La majorité d'entre elles sont virales et bénignes (méningites lymphocytaires aiguës bénignes MLAB), d'autres peuvent être graves

(tuberculose, listériose, herpès)

. La nature des éléments, l'albuminorachie , la glycorachie, la NFS, la CRP et la procalcitonine sont indispensables pour une première approche diagnostique.

Diagnostic étiologique :

I. Etiologie virales

1. Méningo-encéphalite herpétique :

- il s'agit d'une encéphalite nécrosante touchant surtout les lobes temporaux et frontaux.
- La plus grave, peut être mortelle, peut laisser des séquelles
- Due à herpès virus de type 1
- Se rencontre chez l'enfant et l'adulte
- Tableau brutal fait de fièvre, de signes encéphalitiques (convulsions,délire , désorientation, hallucinations..)

Diagnostic :

Électro Encéphalogramme(ondes lentes temporales),
TDM (images hypodenses de nécrose en cocarde, effet de masse).
IRM.

PCR herpès, dans le LCS

Traitement à la moindre suspicion Aciclovir en perfusion (10 15mg/kg/8h) pendant 15-21

2. Entérovirus (les coxackies virus et les Echo-virus) :

- Sont les plus fréquents.
- Ils provoquent des épidémies saisonnières chez les enfants et les nourrissons ; d'évolution généralement favorable

3. Poliovirus :

Certains types sont responsables de la poliomyélite antérieure aiguë (PAA).

- . La fréquence de la PAA a nettement diminué en Algérie depuis la vaccination obligatoire.
- . Elle peut se présenter au début comme méningite lymphocytaire avant que n'apparaissent les paralysies périphériques.
- . D'autres types de poliovirus peuvent provoquer des méningites sans paralysies.

4. Myxovirus : Myxovirus parotidis :

- Responsable des oreillons constitue l'étiologie la plus fréquente du groupe des myxovirus
- La méningite est contemporaine de la parotidite.
- Les oreillons touchent surtout les enfants, adolescents
- Ils se caractérisent par un début brutal, fièvre,et une parotidite bilatérale
- Rougeole : une atteinte méningo encéphalite peut se voir au cours de la rougeole (J5 J7) après l'éruption
- Le vaccin ROR (rubéole, oreillons, rougeole) a été introduit en 2015 dans le programme national de vaccination en Algérie.Grippe : rare

5. VIH :

La primo infection par le VIH peut se manifester par une méningite lymphocytaire.

Il faut rechercher les facteurs de risque et d'autres signes

6. Virus du Nil occidental (West Nile Virus) :

Méningoencéphalite grave transmis par un moustique.

7. Autres virus :

Une méningite lymphocytaire peut être observée au cours de plusieurs infections virales : Mononucléose infectieuse (MNI), hépatites virales, grippe.

II. Etiologies bactériennes :

- Certaines méningites bactériennes se présentent sous forme de méningites à LCR clair de nature lymphocytaire, polynucléaire ou à formule mixte.

- Dans la plupart des cas, l'albuminorachie est élevée, le glucose est bas,

La CRP et la procalcitonine sont élevées.

Graves et urgentes doivent être évoquée en premier :

1) Méningo-encéphalite tuberculeuse :

- Fréquente dans les régions où la couverture vaccinale par le BCG est insuffisante

- C'est la forme la plus grave de la tuberculose.

- Elle toujours secondaire à une TBC pulmonaire, miliaire et réalise souvent une méningo-encéphalite

- Clinique : le tableau est progressif : état fébrile vespéral, anorexie, amaigrissement, des céphalées rebelles, une insomnie, une altération de l'état général.

- Les signes neurologiques sont fréquents : trouble de la conscience, Les signes neurologiques sont fréquents : trouble de la conscience, convulsions, paralysie des paires crâniennes (III, IV, VII+++), déficit moteur

Diagnostic

LCS: clair légèrement hypertendu, clair légèrement hypertendu, lymphocytaire (lymphocytaire quelque fois polynucléaires neutrophiles au début), fois polynucléaires neutrophiles au début), albuminorachie élevée, et surtout une élevée, et surtout une hypoglycorachie (+++)

NFS: leucocytose : leucocytose normale normale

-IDR ++

Radiographie pulmonaire :

Recherche de lésions pleuropulmonaires (caverne, pleurésie, miliaire)

Recherche de Bacilles Acido Alcoolo

Résistants : examen direct et culture (pauci bacillaire),

PCR BK dans le LCR, les urines

Traitement antituberculeux RHZE /

RH au moindre doute.

2) La listériose :

- *Listeria monocytogenes* est un bacille Gram
- C'est une bactérie ubiquitaire que l'on retrouve dans le sol, chez les animaux de ferme.
- Elle résiste à la réfrigération
- La contamination de l'homme se fait par consommation d'aliments contaminés (lait, crème, glace, viande travaillées, Kchir , pâté, charcuterie
- L'infection est grave chez la femme enceinte provoquant la listériose néonatale et quand elle infecte l'encéphale.

La méningite listérienne peut prendre trois aspects :

- Aspect de méningite purulente
- Aspect de méningite virale lymphocytaire, et aspect de méningo encéphalite tuberculeuse.
- Diagnostic : se fait par l'isolement de *Listeria monocytogenes* dans le LCR ou par hémoculture
- Traitement : Amoxicilline 200 mg/kg/j + Gentamycine 2 3 mg/j (21j)

3) Méningites bactériennes décapitées :

- Certaines méningites bactériennes peuvent être décapitées par un traitement Antibiotique traversant la barrière méningée mais à posologie et durée insuffisante
- Le LCR est clair mais fait de polynucléaires
- L'albumine est élevée, la glycorachie basse
- Le germe est absent (examen direct, culture).
- Le diagnostic est redressé par la clinique, la recherche d'Antigènes
- Solubles dans le LCR et parfois dans les urines.

4) Réactions méningées à un foyer de voisinage :

- Une réaction méningée peut s'observer au cours d'une thrombophlébite cérébrale, un abcès cérébral, un empyème...
- Ce sont des réactions méningées à un foyer de voisinage
- Le tableau clinique associe un syndrome méningé plus ou moins franc à des signes encéphalitiques, de localisation. LCR est clair à polynucléaires intacts
- La TDM en urgence faite devant tout trouble de la conscience et/ou des signes de localisation confirme le diagnostic.

5) Leptospiroses :

- Au cours des leptospiroses, l'atteinte méningée est constante biologiquement même si elle manque cliniquement.
- Elles doivent être évoquées devant l'association d'un syndrome hépatorénal, hémorragique chez une personne exposée.
- Le diagnostic est sérologique

6) Brucellose :

peu fréquente. L'atteinte méningée est fréquemment noyée dans un tableau de méningo myélo radiculite. Le diagnostic est évoqué devant un contexte d'exposition et confirmé par les hémocultures et la sérologie (sérodiagnostic de Wright dans le sang et dans le LCR)

III. Autres étiologies :

. Paludisme grave à *Plasmodium falciparum* : réalise une méningo encéphalite grave à évoquer devant tout trouble de la conscience, ou signes méningés au retour d'un voyage en zone impaludée

• Toxoplasmose cérébrale : tableau de méningo encéphalite avec image de nécrose en cocarde et effet de masse à la TDM ou à l'IRM

Se rencontre chez les sujets VIH + au stade de SIDA

• Cryptococcose : Méningite lente due à *Cryptococcus neoformans* observée chez les patients VIH + au stade SIDA

• Méningites cancéreuses : Leucoses aiguë, hémopathies, métastases vertébrales...

Conclusion :

- Diagnostic étiologique difficile
- Parfois d'étiologie inconnue
- Etiologies virales prédominantes
- Evolution spontanément favorable en dehors la méningoencéphalite herpétique
- La tuberculose et la listériose sont les étiologies bactériennes les plus fréquentes